SDD 82 Sujet n°1

Spécialité : Dermatologie

Date : 05/05/24
Auteur : HARDY Quentin (DES dermatologie 2022)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (EDN 2024 MAR Toulouse)

/!\ N'oubliez pas d'indiquer sur le tableur d'avancement que vous construisez une station ECOS

Domaine d'apprentissage principal	Entretien
Domaine d'apprentissage secondaire	Iconographie
Item(s) en lien avec la station	112, 114, 115
Situation(s) de départ en lien avec la station	82 : bulle, éruption bulleuse
Matériel nécessaire à la station	2 chaises, l'iconographie, une table.
Contexte de la station	Aux urgences pédiatriques d'un CHU

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne de garde aux urgences pédiatriques d'un CHU.
Vous recevez Malia, 8 ans, accompagnée de sa mère. Nous sommes le 5 mai.
Vous trouverez des détails dans la lettre du généraliste jointe, qui vous l'adresse.

Paramètres vitaux : température 39,1°C ; glycémie capillaire 0,9 g/L ; TA 102/72 mmHg ; fréquence cardiaque 112 bpm ; fréquence respiratoire : 22 par minute

Malia est inhabituellement bougonne, somnolente. Elle rapporte une douleur intense cutanée, ainsi qu'une gêne très importante aux yeux, et vulvaire.
La surface cutanée atteinte représente 8% de la surface cutanée totale.
Les mains, pieds, coudes, genoux sont épargnés.

Consignes :
Vous devez en 7 minutes

- analyser les 2 images fournies
- rechercher au lit du patient **un** élément paraclinique simple (disponible immédiatement dans le box du SAU), qui est déterminant dans le pronostic
- interroger sa mère, afin de conclure avec une hypothèse diagnostique **et** une hypothèse étiologique.
  Préciser ici avec exactitude le J0 de la maladie.

Vous ne devez pas :

- examiner de patient
- prescrire de traitement
- demander un avis spécialisé

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	Image 1 : chéléite : érosive OU séro-purulente	1 pt	☐
2.	Image 1 : macules érythémateuses du visage	1pt	☐
3.	Image 2 : éruption bulleuse	1pt	☐
4.	Image 2 : décollement en linge mouillé OU signe de Nikolsky positif OU décollement épidermique superficiel OU érosions superficielles	1 pt	☐
5.	Recherche une modification des prises médicamenteuses dans les 21 derniers jours	1 pt	☐
6.	Recherche une auto-médication	1 pt	☐
7.	Demande une saturation en oxygène au doigt/oreille	1 pt	☐
8.	Identifie le J0 de la toxidermie au début du syndrome grippal	1 pt	☐
9.	Recherche une récurrence herpétique chez Malia ou dans son entourage	1 pt	☐
10.	Conclut à un syndrome de Stevens-Johnson possible	1 pt	☐
11.	Retient comme étiologie principale pour l'instant le LAMICTAL	1 pt	☐

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

	8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

TOTAL (max 20 items)	**13 points**

Éléments de rétroaction :

L'identification de la toxidermie grave était assez aisée ici (fièvre élevée, AEG, décollement cutané, atteintes muqueuses multiples, …). Par contre, il faut rapidement interroger de manière précise les parents, afin de pouvoir identifier des médicaments suspects éventuels.

Cela est impératif pour stopper le plus vite possible les médicaments imputables (cet arrêt le plus précoce possible est un facteur pronostique important dans l'évolution de la toxidermie).
Il faut donc rechercher les médicaments prescrits, et tout le reste (auto-médication, phytothérapie, ingestion en cachette des médicaments des parents par les enfants, etc.).

Un point capital est de déterminer le "J0" de la toxidermie.
Souvent, il est mal identifié. En effet, c'est bien les signes généraux (1ères manifestations de la toxidermie) qui sont le J0. Ensuite viennent en général les signes muqueux, et enfin, les signes cutanés !
D'où parfois la méprise : on impute l'antibiotique donné pour cette "grosse grippe", et non le médicament antérieur qui a tout déclenché !

Et bien identifier ce J0 est en plus crucial pour ensuite incriminer des coupables dans les 21 jours environ précédents…

De manière satellite, un point souvent pas clair dans l'externat pour compter les délais d'imputabilité : il faut (pour qu'il soit imputable) absolument que le médicament en question soit encore dans le sang au J0 de la toxidermie. Il faut voir en pratique les demi-vie et la fonction rénale du patient donc.
Et si ici par exemple la patiente débute le LAMICTAL 21 j avant le J0, mais stoppe au bout de 5 jours (demi-vie du médicament environ 1 jour) : pas imputable !

Un Stevens-Johnson idiopathique est possible chez l'enfant ; cela doit néanmoins être affirmé après une enquête très minutieuse et exigeante (hors programme : un bilan toxicologique complet sera ainsi réalisé ; il arrive que les dermatologues appellent toutes les

pharmacies du quartier ou fassent analyser la carte vitale du patient, afin de traquer une prise qui serait passée inaperçue…).

En outre, la nécrose des épithéliums est souvent globale (peau, muqueuses de tout type). Ainsi, une désaturation est impérativement à rechercher précocement. Signe d'une atteinte de l'arbre respiratoire probable, c'est un facteur péjoratif de mortalité (défaillance respiratoire).

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Contexte :
Vous êtes interne de garde aux urgences pédiatriques d'un CHU.
Vous recevez Malia, 8 ans, accompagnée de sa mère.
Vous trouverez des détails dans la lettre du généraliste jointe, qui vous l'adresse.

Paramètres vitaux : température 39,1°C ; glycémie capillaire 0,9 g/L ; TA 102/72 mmHg ; fréquence cardiaque 112 bpm ; fréquence respiratoire : 22 par minute

Malia est inhabituellement bougonne, somnolente. Elle rapporte une douleur intense cutanée, ainsi qu'une gêne très importante aux yeux, et vulvaire.
La surface cutanée atteinte représente 8% de la surface cutanée totale.
Les mains, pieds, coudes, genoux sont épargnés.

Plan de la station ECOS :

Mère simulée en face de l'interne, autour d'un bureau, sur lequel sont disposées les images de Malia, ainsi que la lettre du généraliste.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour Docteur,
J'ai très peur pour Malia qui est très gravement malade. Donnez-lui des antibiotiques très forts s'il vous plaît pour la sauver !!

Identité du patient :

Malia, 8 ans, taille et poids normaux.

Mode de vie :

Développement normal. En primaire. Vit chez ses deux parents.

Comportement global :

Mère très inquiète.

Antécédents personnels :

-Leucémie aiguë lymphoïde (LAL) à l'âge de 2 ans, en rémission complète après chimiothérapie. BACTRIM au long cours depuis.
- Épilepsie, sous LAMICTAL depuis 15 jours

Antécédents familiaux :

- mère : HTA sous AMLOR et diabète de type 2 sous METFORMINE

Médicaments :

- BACTRIM : 3 jours par semaine, depuis l'âge de 2 ans
- LAMICTAL depuis 15 jours
- Depuis le syndrome grippal soit depuis 3 jours : AUGMENTIN (dose poids), DOLIPRANE (dose poids) en continu

Symptômes positifs :

Contexte médicamenteux récent (**à décrire seulement si l'étudiant.e questionne explicitement à ce sujet**) : introduction de LAMICTAL il y a 15 jours par la neurologue, devant l'épilepsie insuffisamment contrôlée (le courrier n'est pas encore parvenu au généraliste).

Pas d'auto-médication en dehors de l'AUGMENTIN et du DOLIPRANE prescrits par le généraliste.
Les médicaments de la mère sont rangés dans un tiroir fermé à clé.

Pas de contage.
Pas de récurrence herpétique récente chez Malia ou l'entourage.

Si l'étudiant demande la saturation en oxygène : **92% (en air ambiant**)

Constantes :

Paramètres vitaux : température 39,1°C ; glycémie capillaire 0,9 g/L ; TA 102/72 mmHg ; fréquence cardiaque 112 bpm ; fréquence respiratoire : 22 par minute

Donnée complémentaire :

- Lettre d'adressage et les 2 images : à remettre au candidat dès le début de l'ECOS

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE DRIVE

Questions de relance :

À 5 minutes si l'étudiant n'a pas demandé la saturation en oxygène, la mère demande : " Vous ne trouvez pas qu'elle a du mal à respirer, Docteur ?"

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Mère de l'enfant en face d'un bureau (où sont la lettre du généraliste, et les 2 images). De l'autre côté : l'étudiant.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Les 2 images (sur tablette, ou imprimées
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours